

Компьютерная и магнитно-резонансная томография в уточняющей диагностике рака пищевода

Аязбаев Ш.У., Бердаuletov С.Б., Шантемиров С.Б., Мукантаев Т.Е.

Мангистауская областная больница,

Медицинский колледж «Мейирбике»,

Мангистауский областной онкологический диспансер, г.Актау

Актуальность проблемы

Несмотря на снижение заболеваемости, рак пищевода (РП) остается одной из частых форм онкологической патологии в Мангистауской области.

Основным методом лечения РП является хирургический. Нередко операции по поводу РП завершаются пробной торакотомией. В связи с этим, несомненно, актуально определение операбельности больных с карциномой пищевода.

Цель

Изучение диагностических возможностей компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в уточняющей распространенности РП.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ КТ, МРТ 18 пациентов с III стадией РП, оперированных в Мангистауской областной больнице и областном онкологическом диспансере в течение 1991-2010 годов. КТ, МРТ выполнены на аппаратах CT Max 640 (General Electric), CT 6800 (Shumadzu), Hi Sheed NX/I (General Electric), MR Max (General Electric), Achieva (Philips) с напряженностью магнитного поля 1.5Т. Нативные и динамические болюсные томографические исследования проводились по собственной методике с пероральным использованием газообразующей смеси. Одновременно осуществлялось КТ желудка.

Результаты

При КТ опухоль пищевода была обнаружена у всех 18 больных с РП. Сравнительно хуже визуализировалась опухоль ретроперикардального сегмента пищевода. КТ не позволила с уверенностью определить степень инвазии стенки пищевода (П) и, только в случае распространения опухоли в околопищеводную жировую клетчатку, можно было высказать мнение об инвазии и паразофагеальном распространении опухоли. В 11 (61%) случаях РП при КТ выявлено исчезновение разделительной жировой прослойки между опухолью П и грудным отделом аорты. Во время операции у 2 (11%) из них установлена интимная спаянность или сращение опухоли П с аортой. В остальных случаях потеря жировой прослойки не означала опухолевую инвазию. Уменьшение и исчезновение triangle fat space, сочетавшееся с широким контактом опухоли и аорты (ширина контакта до 45 градусов обозначен нами термином «проблема 9-12»), имели место в 7 (39%) случаях. Проблема «9-12 часов» при КТ означала инвазию аорты опухолью. Интраоперационно, интимное сращение опухоли с аортой обнаружено в 12 (66,7%) случаях. У 1 (5,5%) пациента удалось выделить пищевод и завершить операцию резекцией первичной пластикой. КТ-заключение о прорастании опухоли и перикард при операции не было подтверждено. При операции у 3 (16,7%) больных выявлено вовлечение в опухолевый процесс непарной вены,

Использование компьютерной и магнитно-резонансной томографии имеют ограниченные диагностические возможности в уточняющей диагностике рака пищевода. Вместе с тем, их применение позволяет снизить уровень эксплоративных хирургических операций по поводу рака пищевода.

A computer and a magnetic resonance tomography have limited diagnostic possibilities in specifying diagnostics of a esophagus cancer. At the same time, their application allows to lower level of explorative surgery for esophagus cancer.

что не установлено при КТ. По КТ в 1 (5,5%) предположено прорастание опухолью непарной вены и данное предположение оказалось достоверным. Наличие при КТ увеличенных околопищеводных лимфатических узлов 5 (27,8%) подтверждено в 2 (11%) случаях и при КТ не обнаружены 7 (39%) случаев поражения лимфатических узлов групп 110, 111, 1, 3. КТ предположение верхней границы РП соответствовала истине в 14 (77,8%) случаев.

МРТ выполнена 5 (27,8%) больным с РП. На МРТ опухоль П отображается сравнительно хуже, чем при КТ, но данный метод лучше демонстрирует взаимоотношение опухоли 11 и аорты, как в аксиальной, так и косо-сагиттальной проекции (аортозофагеальной плоскости). При МРТ в 1 (5,5%) случае обнаружен увеличенный паразофагеальный лимфатический узел и в 2 (11%) случаях не диагностирован увеличенный медиастинальный лимфатический узел.

Выводы

КТ, МРТ имеет ограниченные диагностические возможности в уточняющей диагностике РП. Кроме КТ, МРТ пока не существуют более информативных методов визуализации РП, позволяющих формировать предоперационную концепцию данной патологии. КТ, МРТ позволяют, в определенной степени, определить резектабельность онкобольных с карциномой пищевода и, тем самым, снизить уровень эксплоративных хирургических операций по поводу РП.

Использованная литература

1. Бердаuletov С.Б., Аязбаев Ш.У., Ораз А.Ж. Место компьютерной томографии в выработке предоперационной концепции у больных раком пищевода. Ж. Здравоохранение Казахстана. – 1996 - № 3. - С. 32-34
2. Аязбаев Ш.У., Бердаuletov С.Б., Мукантаев Т.Е., Муратов К.К. Сравнительная оценка КТ-диагностики рака пищевода. Сб. тезисов Респ. научно-практической конференции «Актуальные проблемы клинической хирургии». – Актобинск, 21-22 сентября 2001 - С.49-52.
3. Аязбаев Ш.У., Ораз А.Ж., Шарыгин Р.Р., Досбаев А.С., Шантемиров С.В. Магнитно-резонансная томография в мониторинге консервативной терапии рака пищевода. Сб. тезисов научно-практической конференции. Туркестан, 2002. С. 314-318.